CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Adherencia a Guía de Práctica Clínica – Hiperplasia Prostática Benigna

Parámetro 1. Evaluación diagnóstica integral y clasificación de síntomas

Pregunta de evaluación: ¿Se documentó en la historia clínica una evaluación diagnóstica integral del paciente con sospecha o diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, incluyendo caracterización de síntomas urinarios bajos, evaluación de severidad e identificación de posibles diagnósticos diferenciales?

Descripción de lo que debe registrarse en la historia clínica:
Debe evidenciarse una historia clínica orientada al tracto urinario inferior que incluya:

- Caracterización de síntomas (almacenamiento, vaciamiento y posmiccionales).
- Registro de comorbilidades relevantes (neurológicas, metabólicas u otras).
- Evaluación de medicamentos actuales y hábitos de vida.
- Aplicación o registro del IPSS y clasificación de síntomas (leve, moderado o severo).
- Evaluación del impacto en calidad de vida.
- Consideración de diagnósticos diferenciales (prostatitis, cáncer de próstata u otras causas).

Criterios de calificación

5 – Sí cumple:
Documenta caracterización completa de síntomas urinarios, IPSS o clasificación equivalente de severidad, evaluación clínica integral y valoración diagnóstica.

4 – Cumple adecuadamente:
Describe síntomas urinarios y realiza evaluación parcial, pero no registra IPSS o no clasifica claramente severidad/calidad de vida.

1 – No cumple:
No se evidencia evaluación estructurada de síntomas ni clasificación clínica.

NA- No aplica

Parámetro 2. Examen físico y tacto rectal

Pregunta de evaluación: ¿Se documentó un examen físico orientado al diagnóstico de HPB incluyendo tacto rectal cuando estaba indicado?

Descripción de lo que debe registrarse:
Debe incluir:

- Evaluación abdominal (presencia o no de globo vesical).
- Exploración genital.
- Valoración neurológica básica si aplica.
- Registro del tacto rectal indicando tamaño, consistencia, límites, movilidad, dolor o presencia de nódulos.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple:
Realiza examen físico completo y documenta tacto rectal con descripción clínica.

4 – Cumple adecuadamente:
Registra examen físico parcial o menciona tacto rectal sin describir hallazgos.

1 – No cumple:
No registra examen físico dirigido o no se evidencia valoración prostática cuando estaba indicada.

NA- No aplica

Parámetro 3. Solicitud e interpretación de exámenes iniciales

Pregunta de evaluación: ¿Se documentó la solicitud o revisión de exámenes iniciales recomendados para HPB y la interpretación clínica correspondiente?

Descripción de lo que debe registrarse:
Debe incluir evaluación mediante:

- Uroanálisis.
- Creatinina sérica.
- Glucemia.
- PSA según ruta institucional
- Interpretación clínica y conducta derivada de resultados.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple:
Solicita o revisa exámenes pertinentes, interpreta resultados y define conducta.

4 – Cumple adecuadamente:
Solicita exámenes, pero no interpreta resultados ni define conducta.

1 – No cumple:
No evidencia solicitud ni valoración de exámenes básicos.

NA- No aplica

Parámetro 4. Elección del tratamiento farmacológico

Pregunta de evaluación: ¿El tratamiento instaurado corresponde con las recomendaciones institucionales según severidad clínica, síntomas predominantes y volumen prostático?

Descripción de lo que debe registrarse:
Debe consignarse:

- Medicamento.
- Dosis.
- Justificación clínica.
- Relación con severidad, síntomas predominantes y volumen prostático.
- Contraindicaciones relevantes cuando aplique.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple:
Tratamiento adecuado y justificado según guía.

4 – Cumple adecuadamente:
Formula tratamiento adecuado pero sin justificar elección.

1 – No cumple:
Tratamiento no acorde con recomendaciones o uso de combinaciones contraindicadas.

NA- No aplica

Parámetro 5. Manejo conservador y educación

Pregunta de evaluación:
¿Se registraron recomendaciones no farmacológicas y educación sobre hábitos de vida?

Descripción de lo que debe registrarse:
Debe incluir recomendaciones sobre:

- Reducción de líquidos nocturnos.
- Moderación de cafeína y alcohol.
- Reducción de sodio.
- Control del peso.
- Manejo del estreñimiento.
- Técnicas conductuales (doble micción, entrenamiento vesical).

Criterios de calificación

5 – Sí cumple:
Registra recomendaciones específicas y educación estructurada.

4 – Cumple adecuadamente:
Registra algunas recomendaciones generales.

1 – No cumple:
No evidencia intervención educativa.

NA- No aplica

Parámetro 6. Seguimiento y remisión a urología

Pregunta de evaluación:
¿Se definió conducta de seguimiento o remisión según criterios clínicos?

Descripción de lo que debe registrarse:
Debe incluir:

- Plan de seguimiento.
- Control periódico.
- Remisión a urología ante criterios establecidos (hematuria, RPM >100 ml, sospecha diagnóstica, enfermedad neurológica, falla terapéutica, cirugía previa, etc.).

Criterios de calificación

5 – Sí cumple:
Documenta seguimiento y remisión adecuada.

4 – Cumple adecuadamente:
Menciona seguimiento, pero sin criterios claros.

1 – No cumple:
No documenta seguimiento ni remisión cuando estaba indicada.

NA- No aplica

Parámetro 7. Direccionamiento a manejo quirúrgico por Urología

Pregunta de evaluación: ¿Se documentó una adecuada valoración y direccionamiento a manejo quirúrgico en pacientes con hiperplasia prostática benigna, teniendo en cuenta las indicaciones clínicas establecidas y la selección del abordaje según las características prostáticas?

Descripción de lo que debe registrarse en la historia clínica:
En la atención por urología debe evidenciarse la valoración de criterios de indicación quirúrgica y la definición de conducta correspondiente. La historia clínica debe incluir:

- Evaluación de presencia de complicaciones asociadas a HPB que indiquen manejo quirúrgico:
  - Retención urinaria recurrente.
  - Hematuria refractaria.
  - Cálculos vesicales.
  - Dilatación del tracto urinario superior.
  - Deterioro de función renal asociado.
- Definición del direccionamiento terapéutico (continuar manejo médico, solicitar estudios complementarios prequirúrgicos o remitir a procedimiento).
- En pacientes candidatos, documentar selección del abordaje quirúrgico según tamaño prostático y criterio especializado institucional:
  - Próstata < 60 ml → manejo por vía transuretral.
  - Próstata 60–90 ml → evaluación mediante cistoscopia para definir vía quirúrgica.
  - Próstata > 90 ml → considerar prostatectomía abierta.
- Cuando no se indique cirugía, dejar explícita la justificación clínica del manejo conservador o farmacológico.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple: Se evidencia valoración integral por urología con identificación de indicación quirúrgica y documentación clara de la conducta adoptada (quirúrgica o no quirúrgica), acorde con recomendaciones institucionales.

4 – Cumple adecuadamente: Se documenta decisión quirúrgica o continuidad del manejo; sin embargo, la justificación clínica es incompleta o no se registra claramente el criterio utilizado para definir el direccionamiento.

1 – No cumple: No se documenta conducta frente a indicación potencial de cirugía o el direccionamiento realizado no es consistente con los criterios institucionales establecidos.

NA- No aplica

La metodología de evaluación propuesta fue revisada y validada por el Grupo Estratégico y Clínico de GPC. Durante dicha revisión se consideró que la herramienta presenta preguntas claras y pertinentes para evaluar la GPC de Hiperplasia Prostática Benigna conforme a las recomendaciones trazadoras.